



認知障礙症的長者發病率概況

世界衛生組織指出，認知障礙症是全球導致年長人士殘疾及需要依賴他人照顧的主要原因之一。除患者本身，亦同時為家人及社會帶來一定負擔¹。

雖然認知障礙症一般被視為長者的問題，但一些研究指香港約30%患者²早於65歲³前病發。

根據近期研究，2009年香港60歲以上的認知障礙症患者人數為85,012人，預計至2039年，人數可達332,688人⁴。隨著認知障礙症的長者發病率增加，照顧者將付出更多定期支援及義務照顧。然而，這或會削弱社會及經濟發展。

在香港，2018年的長者護理成本約港幣388億元⁵。而按估計，有關成本在2030年及2040年將分別達到港幣731億元及1,260億元⁵。總括而言，香港人均壽命雖然愈來愈長，但不表示年長人士必定健康，因此，家庭成員所背負的責任，或會影響他們的生計。

您有多了解認知障礙症照顧者的負擔？

經濟情況

68%

受訪者認為患者經濟能力不足



僅 16%

患者受保險計劃保障



支援網絡

36% 受訪者付出



= 1/2 份全職工作

心理健康

接近

80%

受訪者表示在問卷調查時的過去兩週內曾經感到情緒低落、抑鬱或絕望



資訊支援

超過

50%

受訪者提供各種日常護理支援，例如工具性日常生活活動（IADL）⁺、基本日常生活活動（ADL）⁺⁺、財政支援及監管 / 情緒支援

在職的照顧者身兼雙重角色，需求更多時間及資源

工具性日常生活活動 59.6%

財政支援 55.0%

監管/情緒支援 58.5%

日常生活活動 57.9%



在職認知障礙症照顧者及其摯愛可考慮更完善財政規劃，以建立安全網。

⁺ 工具性日常生活活動（IADL）包括購物、準備膳食及服藥等。

⁺⁺ 日常生活活動（ADL）包括飲食、步行及洗澡。

以上的研究結果基於171名在職認知障礙症照顧者在2020年7月至8月進行的網上調查，以及由兩組共17名認知障礙症照顧者在2020年8月進行的網上聚焦小組所得。

認知障礙保障

認知障礙症是一種腦部逐漸衰退的疾病，患者較易有情緒波動及逐漸喪失表達能力。在患病後期，患者需要依賴他人照顧，才可應付其日常生活所需。

滙豐保險明白照顧患有**嚴重認知障礙症**的親人摯愛，無論在身心或經濟上，以至承擔長遠醫療費用，均需面對龐大壓力。所以，我們特意在「滙豐裕達年金計劃」（「滙豐裕達」或「基本計劃」）內推出一項自選附加保障 - **認知障礙保障**（「保障」）。您只需在基本計劃之上繳付額外保費，而受保人一旦確診嚴重認知障礙症，您的經濟狀況可受到適當保障。



投保認知障礙保障前需要知道什麼？

認知障礙保障是「滙豐裕達年金計劃」的自選附加保障：

- 須另繳額外保費；
- 不適用於合計保費金額保單及一年儲蓄期的保單；
- 受保人年齡須介乎**55至70歲³**之間，並須於投保基本計劃時一併投保

有關認知障礙保障的細則、條款、主要風險及不保事項，請參閱有關附加保障單張及附加保障的保單條款。

考慮將來需要

面對診斷結果，應及早制定行動計劃，涵蓋遺產規劃、法律及金錢問題、日常及預定護理計劃。於確診認知障礙症前或不久後整合財政計劃，有助保障您未來經濟實力。另外，研究各類可供利用的財政支援，為未來作好準備。

擔當照顧者角色，需要付出不少時間及金錢⁸。照顧認知障礙症患者，需要考慮即將面對的開支，包括持續治療、伴隨病患到醫生複診及醫治、改裝家居配合日常起居活動、有關安全的開支、日間及全日院舍護理服務等。謹記認知障礙症是漸進式疾病，有關需求將隨時間而改變。

以下是診斷、治療、藥物及日間護理開支，以供基本參考：

診斷認知障礙症過程複雜，亦未有萬應方式，以下是患者遇到的一般情況。圖中資訊僅作基本資料用途，並不構成任何建議或推薦。在作出任何有關治療及藥物的決定前，請諮詢獨立醫療或專家意見。

診斷前	診斷	治療	持續護理
- 香港現有兩種標準測試評估方式： - 蒙特利爾認知評估 (MoCA) - 簡短智能測驗 (MMSE)	- 接受全面徹底的診斷，包括額外頭及頸部測試： - CT電腦斷層掃描 (CT掃描) [#] - MRI磁力共振掃描 (MRI掃描) [#]	- 藥物治療 — 改善記憶力、意識及運作能力，常見藥物包括膽鹼酯酶抑制劑，例如多奈哌齊及美金剛等 (每日服用)。 - 非藥物治療 — 包括認知訓練及其他非藥物介入治療，針對認知缺陷及關乎日常活動的困難，例如記憶診所、職業治療、語言治療、物理治療、音樂治療及自然療法(每月兩次)。	- 日常護理確保患有認知障礙症患者得到妥善照顧： - 針灸 (每月兩次) - 按摩紓緩痛楚及焦慮 (每月兩次) - 護理中心 (每月費用)

預計單次開支：	
- MoCA及MMSE	港幣1,000元
- CT掃描及MRI掃描 [#]	港幣6,570 — 28,790元

預計每月經常開支**：	
- 藥物 (每日服用)	港幣1,460元
- 非藥物治療 (每月兩次)	港幣2,000元
- 日間護理	港幣21,940 — 41,940元
- 針灸 (每月兩次)	
- 按摩 (每月兩次)	
- 護理中心	

[#] 香港的掃描檢查費用差別甚大，原因包括但不限於設施及地點。以上費用僅作一般參考，如有需要，請尋求專業醫療建議。

^{**} 請留意，上圖假設有關於診斷前及診斷測試為單次費用，而治療、藥物及持續護理的每月開支則按所列次數計算。認知障礙症治療費用因人而異，差別甚大。以上費用只供一般參考，如有需要，請尋求專業醫療建議。

認知障礙保障如何運作？

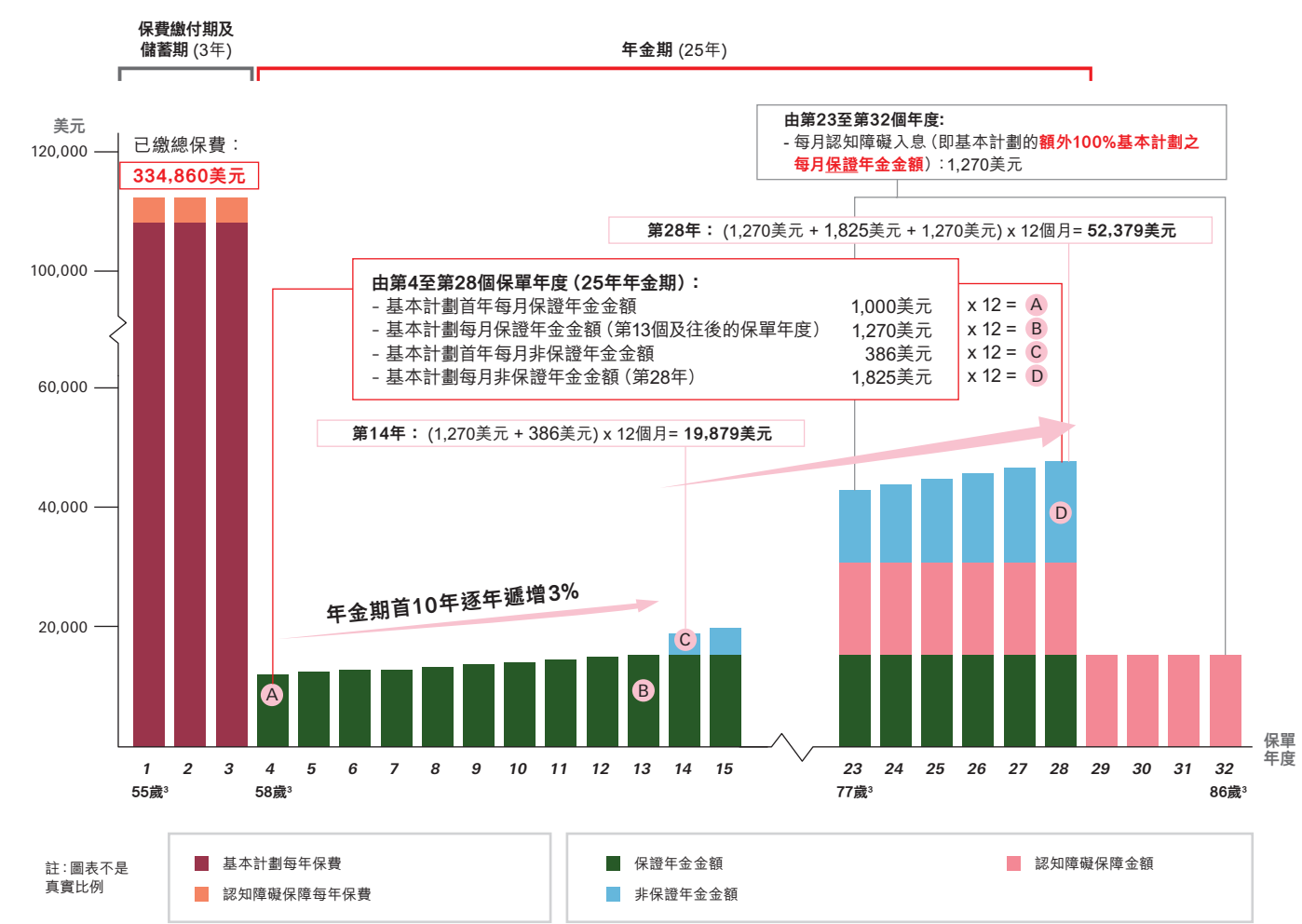


李先生是一位55歲³的專業人士

李先生希望可以在退休日子一直維持穩定收入，因此，計劃在退休後定時收取年金，以應付他與太太的生活開支。當李先生留意到身邊朋友的親人患有嚴重認知障礙症，憂慮自己也會患上此病，希望有所保障，若不幸確診時，可為家人減輕財政負擔。

李先生選擇以「滙豐裕達年金計劃」及認知障礙保障滿足他的所需：

每年保費	基本計劃：107,327美元 認知障礙保障：4,293美元	已繳總保費	334,860美元
保費繳付期/儲蓄期	3年	年金期	25年



於25年年金期間之每月年金金額總額：	563,851美元
直至李先生身故時的每月認知障礙入息總額：	152,400美元
預計每月年金金額加上每月認知障礙入息總額：	716,251美元 → 已繳總保費的214% ⁹

以上例子所述的數字有捨入調整及僅供說明用途。

個案：

- 李先生在首三年內繳清所有保費，並由58歲³（第4個保單年度）開始收取為期25年的每月年金金額¹⁰。
- 他委任基本計劃唯一受益人的太太，作為認知障礙保障收益人。並指定當他於年金期內不幸確診嚴重認知障礙症時，太太可收取基本計劃的每月年金金額（每月年金金額的支付方式必須為「現金提取」）。
- 李先生於77歲³（第23個保單年度）**確診嚴重認知障礙症**。每月認知障礙入息緩解了其家人的經濟困境。

例子假設：

- 以每月形式收取年金金額。每月年金金額乃根據現時的紅利分配及息率預計，並非保證及會不時調整。實際未來金額或會比以上說明的較低或較高。
- 所有保費在繳付保費期到期前全數繳付。
- 在保單期內，沒有提取保單內的任何累積紅利及利息，及沒有作出任何影響紅利的調整。
- 計算累積紅利及累積每月年金金額（如有）時所使用的現時年利率¹⁰為4.0%（適用於美元保單）。
- 可獲享已繳總保費的百分比並非保證。

註：

- World Health Organization. (22 Sep 2020). Ageing and health. Retrieved from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>.
- Chinese University of Hong Kong. 31 May 2016. "CUHK Sets up World's First Research Registry on early onset dementia in Chinese population the youngest age of onset is 38". CUHK Communications and Public Relations Office.
- 年齡指受保人或保單持有人（視乎適用情況而定）於下一次生日的年齡。
- Yu, R., Chau, P. H., McGhee, S. M., Cheung, W. L., Chan, K. C., Cheung, S. H., & Woo, J. (2012). Trends in Prevalence and Mortality of Dementia in Elderly Hong Kong Population: Projections, Disease Burden, and Implications for Long-Term Care. International Journal of Alzheimer's Disease, 2012, 1-6. doi:10.1155/2012/406852.
- Eldercare Hong Kong - The projected societal cost of eldercare in Hong Kong 2018 to 2060.
- Working dementia caregivers: Challenges and Needs, 2020.
- Dementia trends: Impact of the ageing population and societal implications for Hong Kong. 2010. "The cost of institutional care for persons with dementia over the age of 60 would increase from HKD1.6 billion in 2010 to HKD4.2 billion in 2036 and the cost of informal care would go up from HKD10.4 billion to HKD27 billion over the same time". The Hong Kong Jockey Club.
- 可獲享已繳總保費的百分比並非保證。有關假設詳情，請參閱「例子假設」部分。
- 每月年金金額是指每月保證年金金額加每月非保證年金金額（如有）。
- 計算累積紅利及利息／累積每月年金金額（如有）時所使用的現時年利率4.0%（適用於美元保單），此息率並非保證，本公司將會不時自行調整息率。實際息率或會比現時年利率較低或較高。

聲明：

以上圖表所顯示的數字及各價值的相對比例已作捨入調整。實際保障金額將不時調整，或會比上述說明較低或較高。詳情請參閱保險建議書所示數字。以上所刊資料屬一般摘要，只供說明之用，目的並非預測您就此保單可得實際金額。您應同時參閱有關產品冊子、認知障礙保障的附加保障單張、保單條款及保險計劃建議書了解更多詳情。

認知障礙保障是「滙豐裕達年金計劃」的自選附加保障，由HSBC Life (International) Limited 滙豐人壽保險（國際）有限公司（「本公司」或「我們」）承保，並且是本公司而非香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）產品，只擬在香港特別行政區透過滙豐銷售。滙豐為本公司之保險代理商，對於滙豐與您之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心的職權範圍），滙豐須與您進行金融糾紛調解計劃程序；此外，有關於及您上述保單條款及細則的任何糾紛，將直接由本公司與您共同解決。

